carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

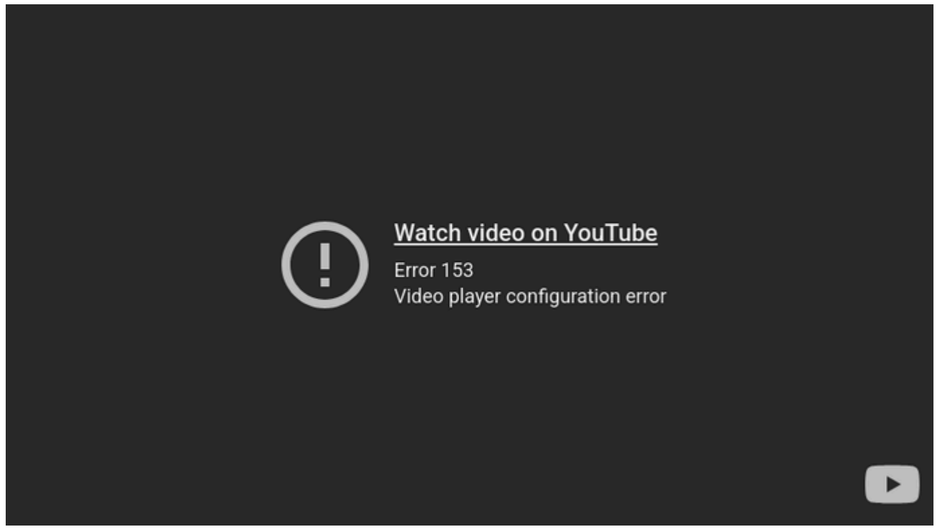
Procedimientos de Ortopedia

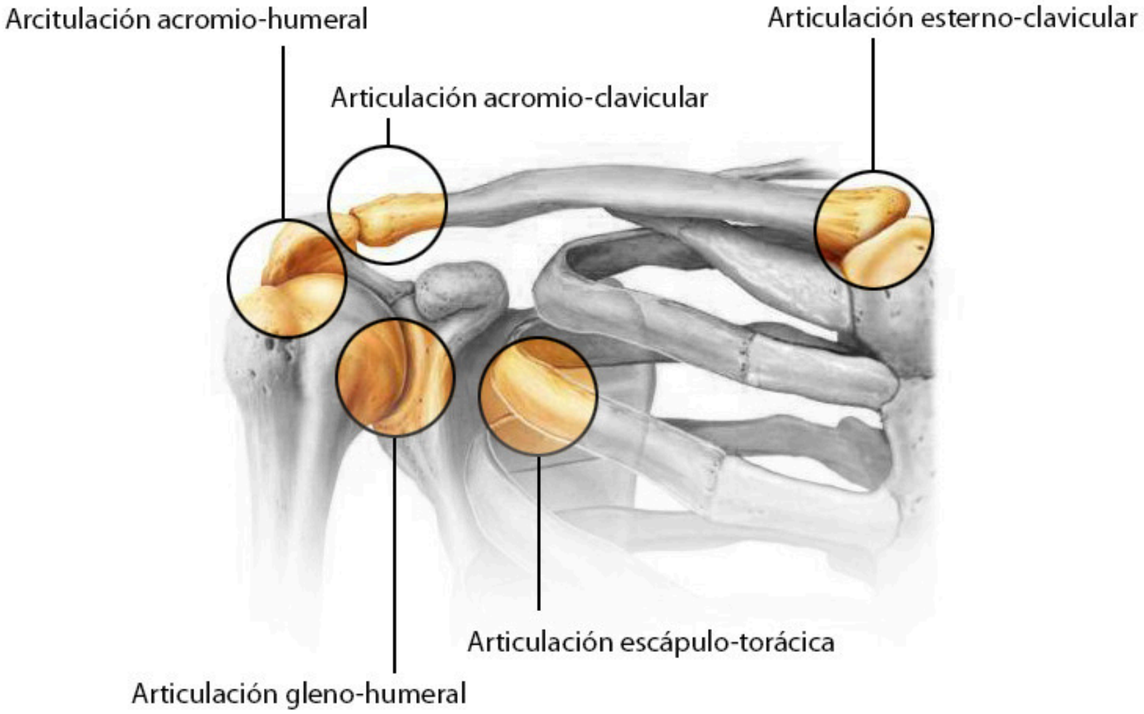
SEMANA 8

Sindrome de hombro doloroso y Hombro congelado

Presente.

Lic.TF Wendy Pacompia Bustincio


Watch video on YouTube
Error 153
Video player configuration error


Arcitulación acromio-humeral
Articulación esterno-clavicular
Articulación acromio-clavicular
Articulación escápulo-torácica
Articulación gleno-humeral

© www.kenhub.com
KEN HUB

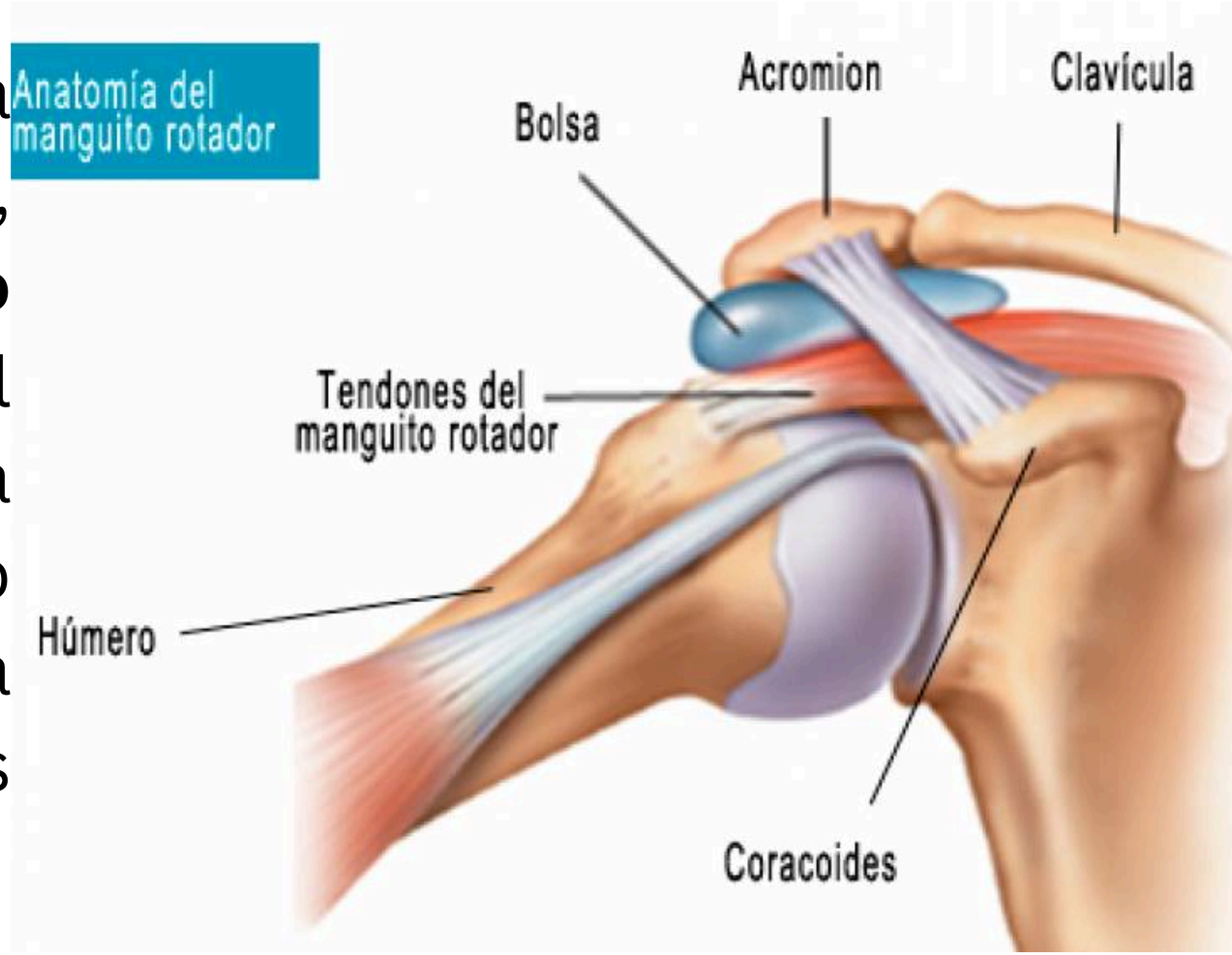
- **Movimientos del hombro:**
- **Rangos de movimiento del hombro:**
- **Movimientos de escápula:**

Síndrome caracterizado principalmente por dolor en región del hombro de diversa etiología.

Frecuentemente causado por inflamación músculo-tendinosa próxima a la región.

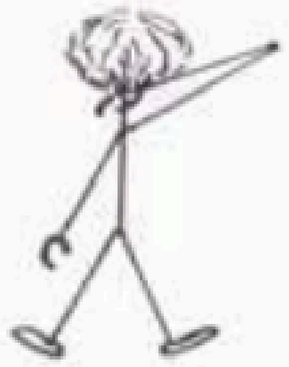
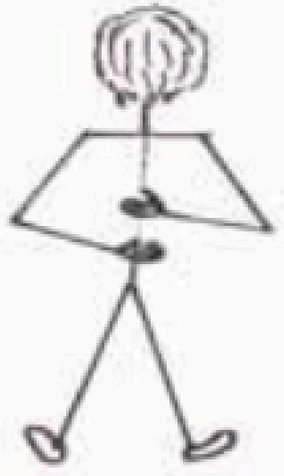
También puede ser por: artropatías, traumatismos, necrosis ósea avascular, neurovasculares, distrofias, enf. Neuromusculares, dolor referido, otras.

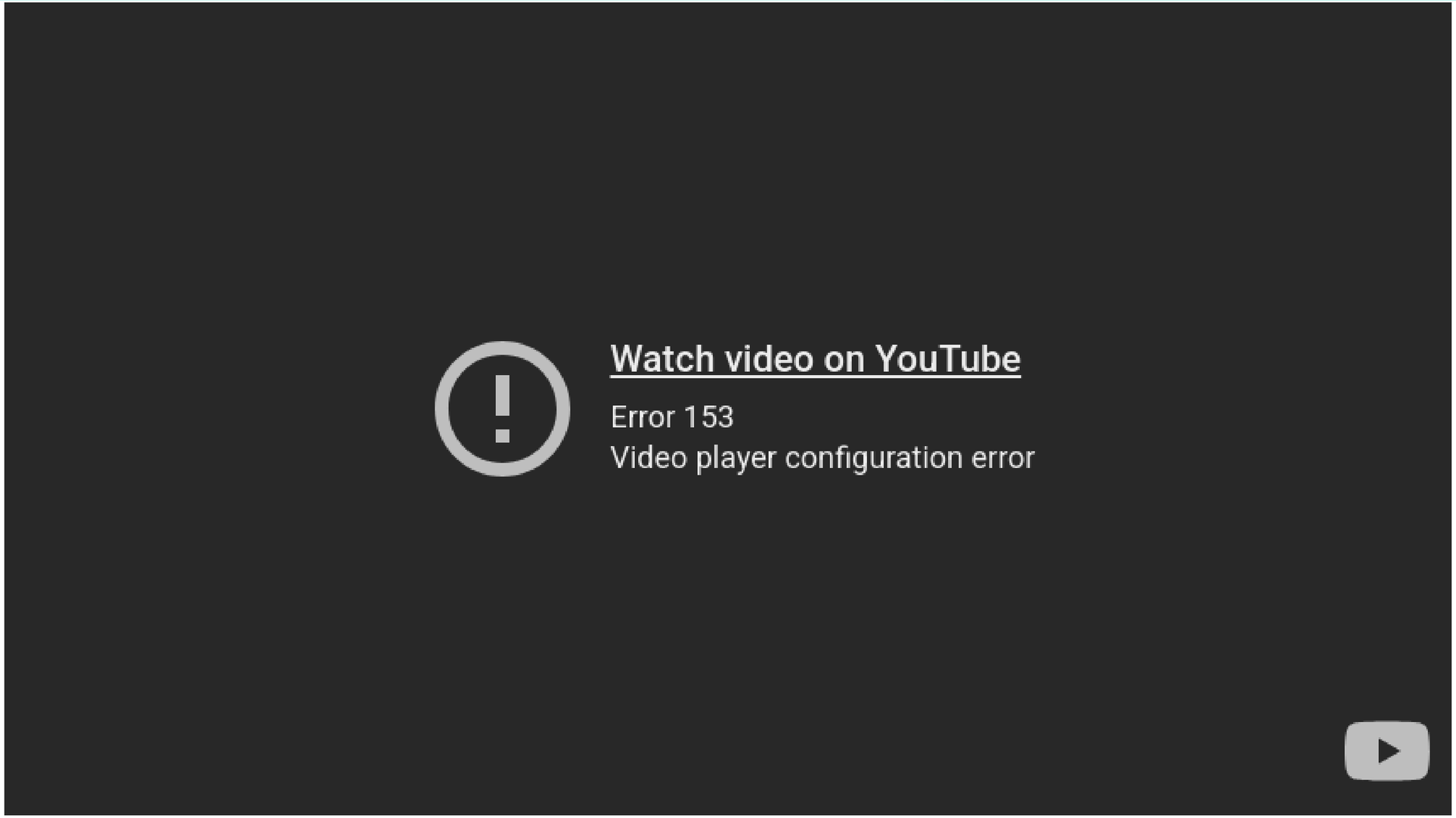
La causa más frecuente es la **patología del manguito rotador**, principalmente por **pinzamiento subacromial** del tendón del músculo supraespinoso, entre la inserción del manguito y el arco formado por acromion y clavícula con los ligamentos acromioclavicular y coracoacromial.



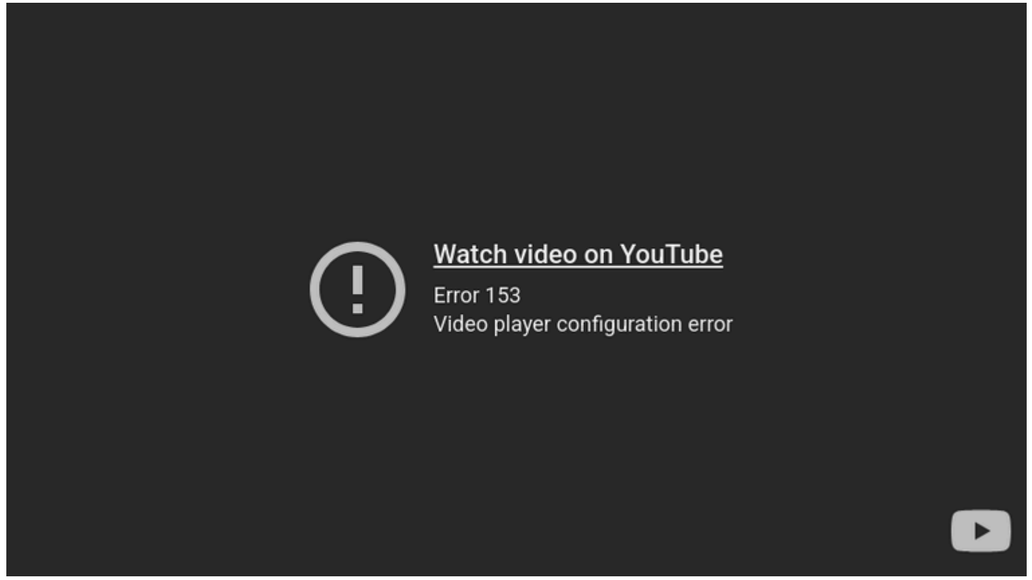
- Dolor en la parte superior y externa del hombro.
- Dolor al mover el brazo, sobre todo por encima de los 90 grados.
- Rigidez articular y dificultad para levantar el brazo.
- Dolor que empeora por la noche, dificultando el sueño.
- Debilidad o pérdida de fuerza.
- Posible irradiación del dolor hacia el cuello, brazo o mano.

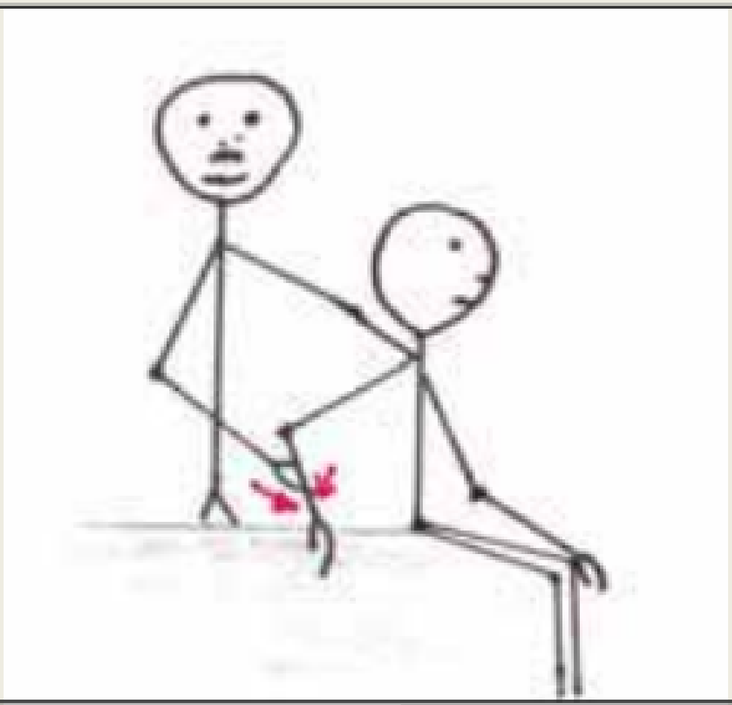
carrión

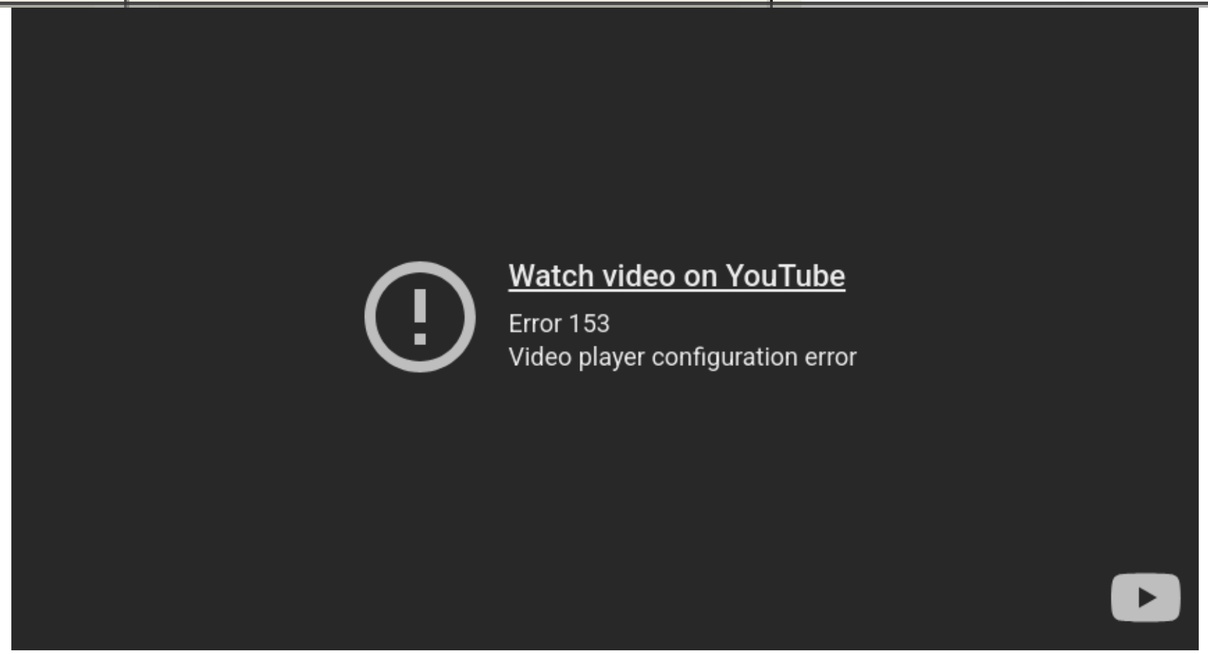
Maniobra	Descripción	Diagnóstico	Figura
Maniobra Apley superior (Schatch –test)	El paciente en bipedestación debe tocarse el margen medial superior de la escapula contralateral con el dedo índice	Valora una enfermedad de manguito de los rotadores (lesión nivel del músculo supraespinoso)	
Maniobra Apley inferior	Paciente bipedestación debe tocarse el hombro opuesto o bien con la punta de los dedos el ángulo inferior de la escapula contralateral.	Valora lesión del manguito de los rotadores (probable músculo subescapular)	

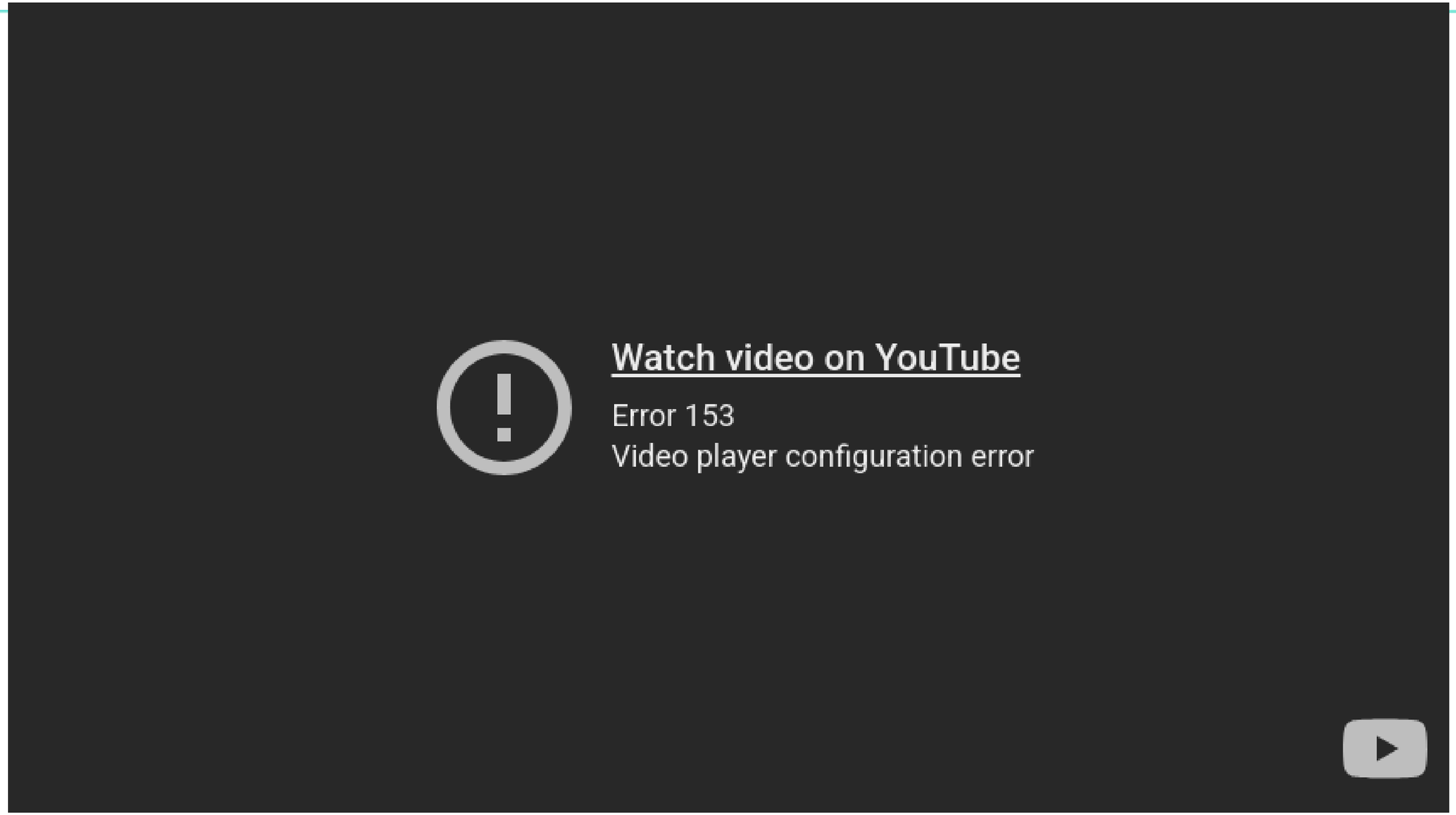

Watch video on YouTube
Error 153
Video player configuration error

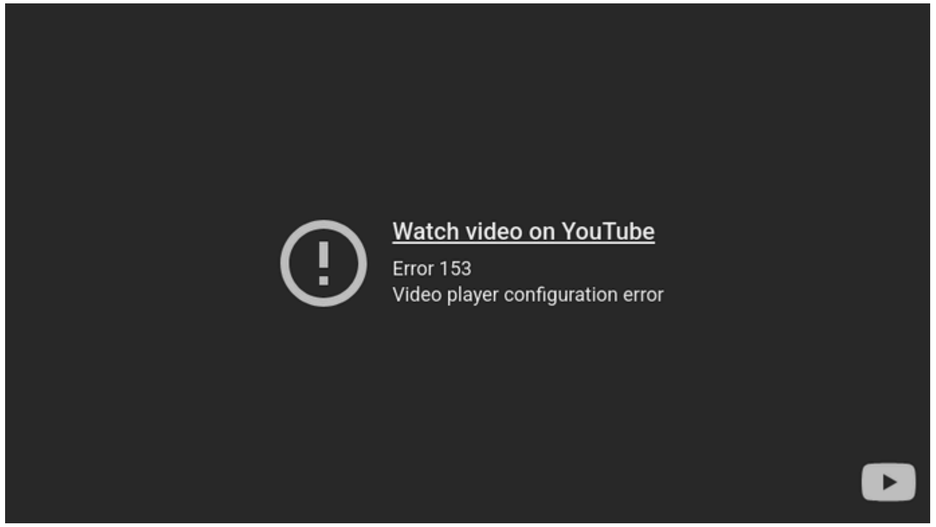
Maniobra de Jobe	El codo en extensión manteniendo el brazo en abducción en 90 °, flexión horizontal de 30° y rotación interna, se efectúa una presión de arriba hacia abajo sobre el brazo.	Valoración del músculo supraespinoso	



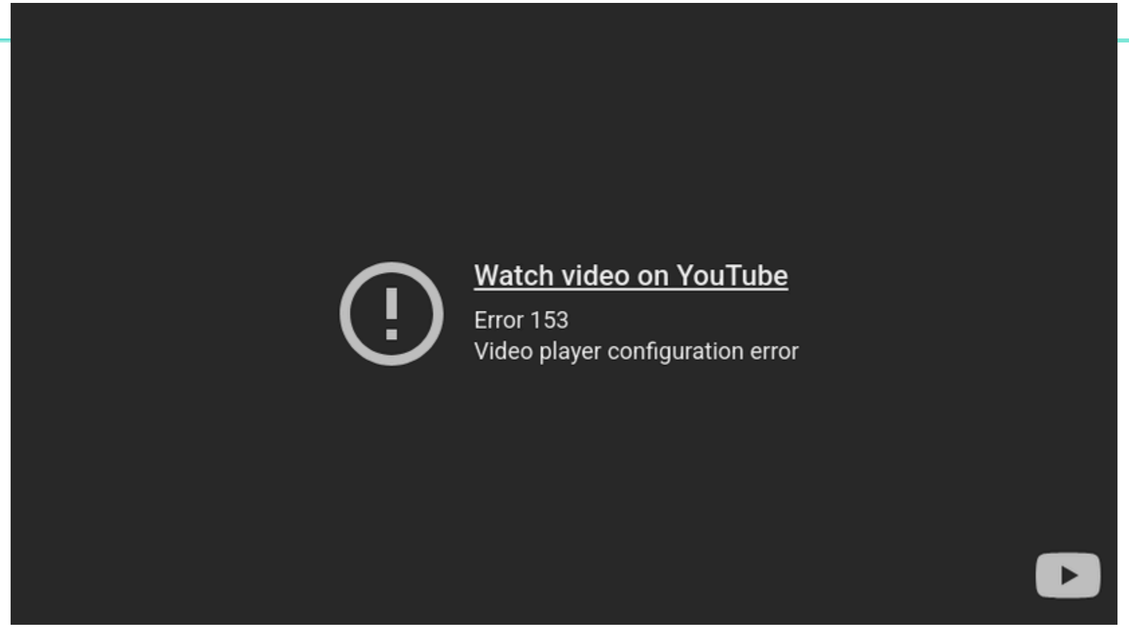
del **pular**	Flexión del codo a 90º por detrás del cuerpo se realiza rotación interna contra resistencia	Valora tendinitis de subescapular o ruptura del mismo	




Watch video on YouTube
Error 153
Video player configuration error



La recuperación de una acromioplastia varía, pero generalmente implica un período inicial de inmovilización (días a 1-2 semanas con cabestrillo), seguido de fisioterapia intensiva para recuperar movimiento y fuerza, con una recuperación funcional en 2 a 4 meses, aunque el alivio total del dolor y la recuperación completa pueden extenderse hasta 6 meses o más, dependiendo de la complejidad y si hubo reparación del manguito rotador.



La recuperación de una reparación artroscópica del manguito rotador es un proceso prolongado que dura de **4 a 6 meses** para una recuperación funcional completa, aunque la cicatrización del tendón toma unas **6-8 semanas iniciales**, con el uso de cabestrillo y fisioterapia gradual. La progresión es lenta, empezando con movilidad pasiva y luego fortalecimiento, y el compromiso del paciente con la rehabilitación es clave para el éxito a largo plazo, pudiendo mejorar hasta más de un año en casos complejos.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

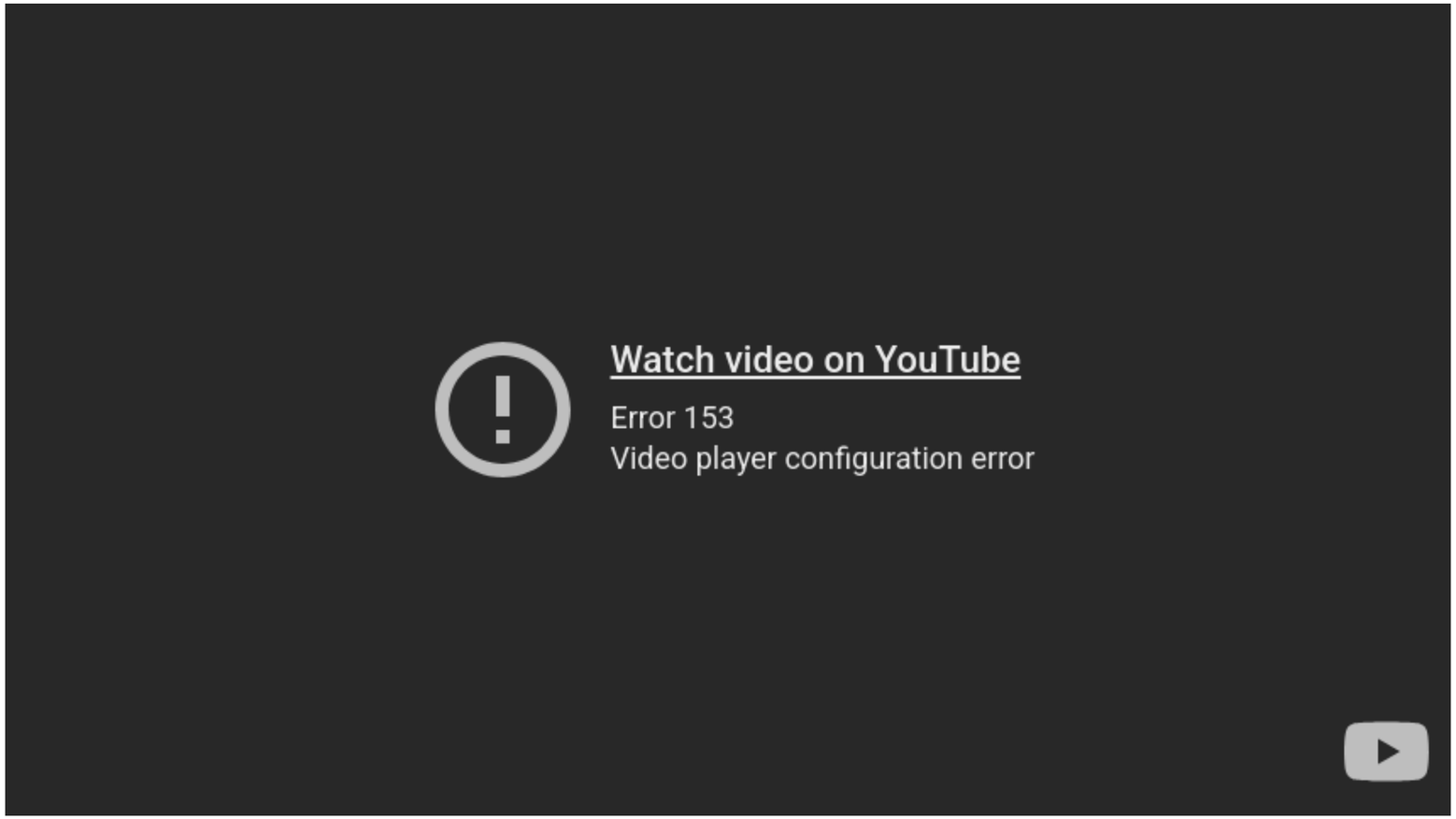
TERAPIA MANUAL

USO DE AGENTES FÍSICOS

HIDROTERAPIA

TERMOTERAPIA

KINESIOTERAPIA


Watch video on YouTube
Error 153
Video player configuration error

EJERCICIOS PARA ESTABILIZAR ESCÁPULA

PROTRUSION
RETRACCION

- **Dolor:** Sordo, en la parte externa del hombro, que puede irradiarse al brazo y empeorar al acostarse, interrumpiendo el sueño.
- **Rigidez:** Dificultad para mover el hombro en todas direcciones (flexión, abducción, rotación externa e interna).
- **Limitación de movimiento:** Incapacidad para realizar actividades como levantarse el brazo, alcanzar objetos o vestirse.

- **Fase de Congelación (2-9 meses):** El dolor aumenta lentamente y la rigidez se vuelve más pronunciada, limitando el movimiento.
- **Fase Congelada (4-12 meses):** El dolor puede disminuir, pero la rigidez es máxima, haciendo que las tareas diarias sean muy difíciles.
- **Fase de Descongelación (6-24 meses o más):** El dolor se reduce y la movilidad comienza a mejorar gradualmente hasta una recuperación casi completa.

En esta fase el objetivo no es “forzar” el hombro, sino **mantener la movilidad sin irritar la cápsula** y enseñar al paciente estrategias para controlar el dolor.

En esta etapa el dolor va cediendo, pero la rigidez es máxima. El foco está en **mantener la función y evitar mayor pérdida de rango**.

En esta fase el paciente comienza a recuperar movimiento de forma gradual. El objetivo es **recuperar fuerza y movilidad completa** lo antes posible.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.